

LA RELATION MEDECIN-MALADE L'EXAMEN GYNECOLOGIQUE



MOTS-CLES

- Alliance thérapeutique
- Mise en confiance
- Empathie
- Consentement explicite
- Respect de la pudeur
- Examen des seins
- Palpation abdominale
- Inspection vulvaire
- Examen au spéculum
- Toucher vaginal



OBJECTIFS EDN : Item N°1

L'item de connaissance 1 est vaste : « La relation médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein d'une équipe, le cas échéant pluriprofessionnelle. La communication avec le patient et son entourage. L'annonce d'une maladie grave ou létale ou d'un dommage associé aux soins. La formation du patient. La personnalisation de la prise en charge médicale. »

Etant donné que vous êtes nombreux à passer en stage en gynécologie et à prendre des gardes aux urgences gynécologiques, nous avons choisi ici de nous focaliser sur la relation soignant.e – patiente au cours de l'examen gynécologique.

Rang	Rubrique	Intitulé	Acquis
A	Définition	Connaître la définition de la relation médecin-malade	
A	Définition	Connaître la notion d'empathie clinique	

1. INTRODUCTION



RANG A : Connaître la définition de la relation médecin-malade

La relation médecin-malade correspond à la relation entre un soignant et une personne soignée dans une approche bio-médico-psychosociale centrée sur le patient.e et pas que sur sa pathologie. Cette relation vise à établir la **confiance**, condition première de l'adhésion du patient et de l'**alliance thérapeutique**. Elle est fondée sur l'écoute, l'empathie, le respect, l'examen physique, la clarté et la sincérité du langage afin de faire du patient un partenaire de soin, dans le lequel sera intégré son expérience et son vécu.



RANG A : Connaître la notion d'empathie clinique

- ⇒ L'empathie d'un soignant est définie par **sa capacité à comprendre et à partager ce qu'éprouve le malade, ses émotions et sa souffrance.**
- ⇒ L'examen gynécologique avec l'examen au spéculum et le toucher vaginal sont craints par beaucoup de femmes.
- ⇒ La **pertinence de réaliser un examen touchant à l'intimité** d'une personne doit toujours être réinterrogée. Cependant, l'examen clinique gynécologique reste en dépit des progrès de l'imagerie, nécessaire au diagnostic de nombreuses maladies. Dans ce cas, il est indispensable d'expliquer pourquoi et de prévenir la patiente en amont du risque d'inconfort ou de douleur.
- ⇒ **Le consentement de la femme pour un examen gynécologique ne doit plus être tacite ou présumé**, mais être **explicite et différencié pour chacun des examens pratiqués** durant une consultation.
- ⇒ Un examen gynécologique doit être réalisé dans le souci de la dignité du patient, de sa pudeur et de sa moindre souffrance : **expliquez bien le déroulement de l'examen gynécologique avant et pendant**, expliquer vos gestes, rassurez, prévenez en amont du risque de douleur provoquée.
- ⇒ **Nécessité de prendre en compte les réticences et les refus** : le refus d'un examen ne doit pas entraîner une interruption brutale de la consultation ni une rupture de la relation de soin.
- ⇒ Une partie des femmes qui seront amenées à vous consulter ont été victimes de violences sexuelles. Les soignants se doivent d'être vigilants pour dépister les violences faites aux femmes avec un questionnement plus systématique (NDLA : fait avec tact, ça demande de la formation et de l'intelligence émotionnelle) Ces violences ne sont souvent pas avouées dès la première consultation et nécessite la mise en place d'une relation de confiance avec la patiente.



IMPORTANT, CELA VOUS CONCERNE

Avis 142 du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE), 16 février 2023, « Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques et touchant à l'intimité ».

« Les étudiants en santé ont besoin d'apprendre à réaliser des examens intimes. Si la simulation et l'utilisation de mannequins participent à leur formation, ceux-ci ne peuvent totalement se substituer à l'apprentissage en vie réelle. Afin que les futurs professionnel(le)s puissent acquérir progressivement la maîtrise des gestes qui constitueront le cœur de leur pratique professionnelle, les patient(e)s sont invitée(e)s, lorsque leur état émotionnel le permet, à accepter cette présence, à en comprendre le sens et les enjeux. Cette participation individuelle à la formation des futur(e)s professionnel(le)s de santé relève d'un engagement civique indispensable à la préservation de la santé publique, qui est un bien commun. **Le consentement préalable des patient(e)s à la présence d'étudiant(e)s, ou à la réalisation d'examens par des étudiant(e)s, doit être recherché après la délivrance d'une information adaptée.** Ce consentement doit être explicite, il ne peut être présumé du seul fait que l'on se situe dans un centre hospitalo-universitaire par exemple. Les patient(e)s devraient être libres d'accepter ou de refuser et leur refus éventuel devrait être respecté. »

2. INTERROGATOIRE AU COURS DE L'EXAMEN GYNECOLOGIQUE

2.1. ANTECEDENTS



ATTENTION REFLEXE

- ⇒ Nous sommes étonnés lors des examens ECOS du nombre d'étudiants qui oublient de commencer l'entretien médical par la recherche des antécédents ! Beaucoup se focalisent sur le motif de consultation et passent à côté de pas mal de choses...
- ⇒ Exemple pour un ECOS de demande de contraception : les étudiants oublient très souvent de demander les antécédents familiaux thromboemboliques au premier degré, ce qui constitue une contre-indication formelle aux oestroprogestatifs.
- ⇒ Soyez systématique quand vous interrogez et surtout allez assister aux consultations au cours de vos stages pour apprendre à interroger les patient.e.s !

MEDICAUX ET CHIRURGICAUX	Interrogatoire complet insistant sur les antécédents obstétricaux et gynécologiques .
GYNECOLOGIQUES	⇒ Age des 1^{ères} règles ⇒ Durée habituelle et régularité du cycle ⇒ Déroulement des règles (durée, douleur, abondance, syndrome prémenstruel) ⇒ Age des 1^{ers} rapports sexuels ⇒ pas d'examen gynécologique chez la femme vierge ⇒ ATCD de vaccination anti-HPV ⇒ Contraception (préciser le type, la durée, la tolérance et l'observance) ⇒ Date des dernières règles (DDR) ⇒ Antécédents particuliers : kyste ovarien, torsion d'annexe, salpingite, grossesse extra-utérine (GEU), endométriose... ⇒ Age de la ménopause, prise ou non d'un traitement hormonal de la ménopause (THM). ⇒ Interrogatoire à adapter au motif de la consultation gynécologique : savoir aborder avec tact, empathie et pudeur la qualité de vie sexuelle, dépistage d'antécédents de violences sexuelles
OBSTETRIQUES	Gestité (G) et parité (P). Cf. Tableau. Pour chaque enfant : ⇒ Mode d'obtention de la grossesse : spontanée ou après Assistance Médicale à la Procréation ⇒ Déroulement de la grossesse avec recherche d'un antécédent de grossesse pathologique ⇒ Mode d'accouchement (voie basse, extraction instrumentale, césarienne) ⇒ Episiotomie, notion de traumatisme périnéal ⇒ Poids du bébé, mode d'allaitement maternel/artificiel/mixte.
FAMILIAUX	⇒ Hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie familiale, ⇒ Rechercher des antécédents familiaux au premier degré d'accidents vasculaires thrombo-emboliques veineux et artériels avant 55 ans (et bien le noter par écrit dans votre dossier : c'est très important si vous êtes amenés à prescrire des traitements à base d'oestrogènes – situation fréquente en gynécologie – Cf Chapitre Contraception) ⇒ Antécédents de cancer du sein et de toute autre pathologie tumorale (ovaire, utérus, côlon)